MINDEN HÉTEN EGY ESET™ · 1. BÓNUSZ

100 kommentált esetkérdés

Rövid klinikai adatok, egy kérdés, négy válaszlehetőség. 100 eset 10 blokkban; minden blokk végén megoldókulcs és rövid kommentár arról, miért helyes a válasz.

Tartalom

Hogyan dolgozz vele

1. blokk · Alapdiagnózis és osztályozás · 1–10. kérdés

2. blokk · Kefalometria · 11–20. kérdés

3. blokk · Tervezés és időzítés · 21–30. kérdés

4. blokk · Helygazdálkodás · 31–40. kérdés

5. blokk · Lehorgonyzás és minicsavarok · 41–50. kérdés

6. blokk · II. osztály · 51–60. kérdés

7. blokk · III. osztály · 61–70. kérdés

8. blokk · Vertikális és Transzverzális Problémák · 71–80. kérdés

9. blokk · Kiegészítő Mechanikák · 81–90. kérdés

10. blokk · Befejezés, retenció, trauma és ankilózis · 91–100. kérdés

Következő lépés

KEZDÉS

Hogyan dolgozz vele

Egy blokk nagyjából 15 perc. Hetente egy blokk, párhuzamosan az 52 hetes programmal.

1. **Oldd meg a blokkot időre.** A válaszaidat írd a kérdés mellé; a megoldókulcsba ne nézz bele.
2. **Vesd össze a kulccsal.** Olvasd el a kommentárt azoknál a kérdéseknél, amelyeket elrontottál, vagy amelyeket bizonytalanul találtál el.
3. **Térj vissza a forráshoz.** Minden blokk elején ott áll a Kézikönyv megfelelő modulja és a vizuális térképek száma.
4. **Írd fel a pontszámod.** A blokk végi sorba jegyezd fel a helyes válaszok számát és a dátumot; egy hónap múlva oldd meg újra ugyanazt a blokkot.

BLOKK	TÉMA	JAVASOLT HÉT
1–2	Alapdiagnózis, kefalometria	Az 1–11. hét alatt vagy után
3	Tervezés és időzítés	12–16. hét
4–5	Helygazdálkodás, lehorgonyzás és minicsavarok	17–23. hét
6–7	II. osztály, III. osztály	24–31. hét
8	Vertikális és Transzverzális Problémák	32–38. hét
9	Kiegészítő Mechanikák	39–43. hét
10	Befejezés, retenció, trauma és ankilózis	44–52. hét

Az esetek oktatási célúak

Az adatok kitaláltak, és egyetlen fogalom mérésére egyszerűsítettük őket. Valódi páciensnél a döntés teljes vizsgálat és dokumentáció alapján születik.

1. BLOKK · 1–10. KÉRDÉS

Alapdiagnózis és osztályozás

Olvasmány: 1. modul · Alapok és az Okklúzió 6 Kulcsa; 2. modul · Átfogó Diagnosztika · Vizuális térképek: 1, 2, 9, 10, 17, 37, 38

1. kérdés

ESET

13 éves. Moláris viszony mindkét oldalon teljes egységnyi II. osztály. Overjet 8 mm, a felső metszők proklináltak.

Mi az Angle-féle besorolás?

A) II. osztály 1. alosztály
B) I. osztály
C) II. osztály 2. alosztály
D) III. osztály

2. kérdés

ESET

15 éves. Moláris viszony II. osztály. A felső centrálisok retroklináltak, a laterálisok proklináltak, mély overbite.

Melyik a legvalószínűbb besorolás?

A) II. osztály 1. alosztály
B) I. osztály mélyharapással
C) Pszeudo-III. osztály
D) II. osztály 2. alosztály

3. kérdés

ESET

10 éves. Jobb oldalon moláris I. osztály, bal oldalon fél egységnyi II. osztály. Az alsó középvonal 2 mm-rel balra tér el.

Mi az első teendő?

A) Azonnal II. osztályú elasztikus indítása a bal oldalon
B) Bal felső premoláris extrakciójának tervezése
C) A harapás ellenőrzése centrikus relációban, a funkcionális csúszás elkülönítése a valódi aszimmetriától
D) Egy év várakozás minden beavatkozás nélkül

4. kérdés

ESET

9 éves. Jobb oldali hátsó kereszttharapás. Centrikus relációban a középvonalak egybeesnek, centrikus okklúzióban az alsó középvonal jobbra tér el.

Mi a legvalószínűbb diagnózis?

A) Valódi mandibuláris aszimmetria

B) Szűk felső állcsont miatti funkcionális csúszás

C) Egyetlen fogra korlátozódó dentális kereszttharapás

D) TMI-ankilózis

5. kérdés

ESET

25 éves. Nyugalmi helyzetben túl sok látszik a felső metszőkből. A felső ajak hossza és a koronák hossza normális. Mosolykor feltűnő az íny.

Melyik okra gondolsz elsősorban?

A) Vertikális maxilláris túlnövekedés vagy felső dentoalveoláris extrúzió

B) Rövid felső ajak

C) Passzív áttörés

D) Mandibuláris retrúzió

6. kérdés

ESET

11 éves. A jobb felső szemfog buccalisan nem tapintható, a bal oldali igen. A tejszemfog a helyén van.

Melyik a helyes megközelítés?

A) Két év várakozás dokumentáció nélkül

B) Azonnali sebészi feltárás és trakció

C) A tejszemfog ellenőrzés nélkül hagyása

D) A helyzet felmérése panorámaröntgennel, szükség esetén kiegészítő (3D) képalkotás tervezése

7. kérdés

ESET

Az alsó ívben 7 mm torlódás van. Az alsó Spee-görbe kb. 3 mm.

Hogyan értelmezed legjobban az alsó ív teljes helyigényét?

A) Pontosan 7 mm

B) 4 mm, a Spee-görbe helyet nyer

C) Több mint 7 mm; a Spee-görbe kiegyenlítése is helyet igényel

D) A Spee-görbét a helyelemzés nem veszi figyelembe

8. kérdés

ESET

A Bolton-elemzésben magas az anterior arány: az alsó frontfogak a felsőkhöz képest nagyok.

Melyik megoldás jöhet szóba?

A) A Bolton-eltérésnek nincs klinikai hatása

B) IPR az alsó frontrégióban vagy a felső laterális metszők restauratív megnagyobbítása

C) Felső premoláris extrakció kötelező

D) Gyors felső állcsont-tágítás szükséges

9. kérdés

ESET

14 éves. Szájnyitáskor balra deviál, a jobb TMI-ben kattanás. Fájdalom nincs.

Mit teszel a kezelés előtt?

A) Rögzíted a leletet a kiinduló dokumentációban, tájékoztatod a pácienst és a családot, szükség esetén további vizsgálatot kérsz

B) Mivel nincs fájdalom, nem jegyzed fel

C) Mindenképp elutasítod a kezelést

D) Azonnal funkcionális készüléket helyezel be

10. kérdés

ESET

8 éves. Az alsó maradó metszőkön kb. 2 mm torlódás. A tejszemfog és a tejmolárisok a helyükön vannak.

Melyik a helyes értelmezés?

A) Mindenképp premoláris extrakció kell

B) Gyors felső állcsont-tágítás kötelező

C) Azonnal el kell kezdeni a rögzített kezelést

D) Vegyes fogazatban gyakori; helyelemzéssel és a leeway-tér figyelembevételével követjük

1. blokk · Válaszok és kommentárok

KÉRDÉS	VÁLASZ	KOMMENTÁR
1	**A**	**II. osztály 1. alosztály.** A megnövekedett overjet és a proklinált felső metszők az 1. alosztályra utalnak. A szkeletális eredetet külön, kefalometriával értékeljük.
2	**D**	**II. osztály 2. alosztály.** A retroklinált centrálisok, a proklinált laterálisok és a mélyharapás a 2. alosztály tipikus mintázata.
3	**C**	**A harapás ellenőrzése centrikus relációban, a funkcionális csúszás elkülönítése a valódi aszimmetriától.** Az egyoldali osztálykülönbség és a középvonal-eltérés először CR–CO ellenőrzést kíván; a mechanikát csak az ok tisztázása után választjuk.
4	**B**	**Szűk felső állcsont miatti funkcionális csúszás.** Ha centrikus relációban a középvonalak rendeződnek, az a funkcionális csúszás fő jele.
5	**A**	**Vertikális maxilláris túlnövekedés vagy felső dentoalveoláris extrúzió.** Ha az ajakhossz és a koronahossz normális, az ínymosoly hátterében vertikális maxilláris és dentoalveoláris okok állnak.
6	**D**	**A helyzet felmérése panorámaröntgennel, szükség esetén kiegészítő (3D) képalkotás tervezése.** Az egyoldali nem tapinthatóság retineált szemfogra figyelmeztet; először a helyzetet és a szomszédos gyökereket értékeljük.
7	**C**	**Több mint 7 mm; a Spee-görbe kiegyenlítése is helyet igényel.** A mély Spee-görbe kiegyenesítése többlethelyet kíván az ív kerületén.
8	**B**	**IPR az alsó frontrégióban vagy a felső laterális metszők restauratív megnagyobbítása.** A fogméret-eltérés a befejezésnél befolyásolja az overjetet és a kontaktpontokat; IPR-rel vagy restauratív korrekcióval kiegyenlíthető.
9	**A**	**Rögzíted a leletet a kiinduló dokumentációban, tájékoztatod a pácienst és a családot, szükség esetén további vizsgálatot kérsz.** A TMI-leleteket a kezelés kezdete előtt dokumentálni kell; a pácienst tájékoztatjuk, és szükség esetén további vizsgálat következik.
10	**D**	**Vegyes fogazatban gyakori; helyelemzéssel és a leeway-tér figyelembevételével követjük.** Korai vegyes fogazatban gyakori az enyhe alsó metszőtorlódás; követés és helyelemzés alapján döntünk.

Helyes válaszok: ___ / 10 Dátum: Ismétlés dátuma:

2. BLOKK · 11–20. KÉRDÉS

Kefalometria

Olvasmány: 2. modul · Átfogó Diagnosztika · Vizuális térképek: 3, 40, 41, 42 · Kefalometriai mérési gyakorlófüzet

11. kérdés

ESET

SNA 82°, SNB 76°, ANB 6°.

Melyik a legpontosabb értelmezés?

A) Túlnyomóan maxilláris prognátiával járó szkeletális II. osztály

B) Szkeletális I. osztály

C) Szkeletális III. osztály

D) Túlnyomóan mandibuláris retrúzióval járó szkeletális II. osztály

12. kérdés

ESET

SNA 86°, SNB 80°, ANB 6°.

Melyik a legpontosabb értelmezés?

A) Túlnyomóan mandibuláris retrúzióval járó szkeletális II. osztály

B) Szkeletális III. osztály

C) Túlnyomóan maxilláris prognátiával járó szkeletális II. osztály

D) Normális szagittális viszony

13. kérdés

ESET

ANB 2°, Wits +5 mm. Az SN-sík feltűnően dőltnek látszik.

Hogyan értelmezed?

A) Mivel az ANB normális, a páciens biztosan szkeletális I. osztályú

B) Az ANB félrevezető lehet; a Wits-értékkel, a profillal és más mérésekkel együtt értékeljük

C) A Wits-értéknek nincs klinikai jelentősége

D) Az SN dőlése nem hat az ANB-re

14. kérdés

ESET

FMA 34°, SN-GoMe 40°.

Milyen a vertikális mintázat?

A) Hiperdivergens

B) Hipodivergens

C) Normodivergens

D) Ezekkel az értékekkel nem ítélhető meg

15. kérdés

ESET

FMA 18°. Mély overbite.

Melyik állítás igaz erre a vertikális mintázatra?

A) A moláris extrúzió szigorúan ellenjavallt

B) Nagy a nyitott harapás kockázata

C) A vertikális kontrollhoz a hátsó intrúzió az elsődleges

D) A hátsó extrúziót jobban tolerálja, de erős a mélyharapásra való hajlam

16. kérdés

ESET

IMPA 102°. II. osztályú kamuflázshoz hosszan tartó II. osztályú elasztikust terveznek.

Mi a legfontosabb kockázat?

A) Az alsó metszők retroklinációja

B) A felső molárisok intrúziója

C) Az alsó metszők proklinációjának további fokozódása; parodontális és stabilitási kockázat

D) Az overbite spontán növekedése

17. kérdés

ESET

U1-SN 115°. Overjet 8 mm, ANB 3°.

Melyik a legpontosabb értelmezés az overjetre?

A) Az overjet teljes egészében szkeletális

B) Az overjet jelentős része a felső metszők proklinációjából ered

C) A felső metszők retroklináltak

D) A metszők dőlésének nincs köze az overjethez

18. kérdés

ESET

III. osztályú páciens. ANB −3°, IMPA 80°, U1-SN 112°.

Mit mutat a metszők dőlése?

A) Természetes dentoalveoláris kompenzáció: a felső metszők proklináltak, az alsók retroklináltak

B) A dekompenzáció befejeződött

C) Mindkét metsző dőlése normális

D) A felső metszők retroklináltak, az alsók proklináltak

19. kérdés

ESET

A tracingen a mandibuláris síkot rajzolod be.

Az SN-GoMe szöghöz a mandibuláris sík mely pontokon halad át?

A) Porion és Orbitale

B) Sella és Nasion

C) ANS és PNS

D) Gonion és Menton

20. kérdés

ESET

Az FMA méréséhez a frankfurti horizontálist rajzolod be.

Mely pontok határozzák meg a frankfurti síkot?

A) Sella és Nasion

B) ANS és PNS

C) Porion és Orbitale

D) Gonion és Menton

2. blokk · Válaszok és kommentárok

KÉRDÉS	VÁLASZ	KOMMENTÁR
11	**D**	**Túlnyomóan mandibuláris retrúzióval járó szkeletális II. osztály.** Az SNA normális, az SNB alacsony: a különbséget a mandibula adja.
12	**C**	**Túlnyomóan maxilláris prognátiával járó szkeletális II. osztály.** Az SNB normális, az SNA magas: a különbséget a maxilla adja.
13	**B**	**Az ANB félrevezető lehet; a Wits-értékkel, a profillal és más mérésekkel együtt értékeljük.** Az ANB-t befolyásolja az SN-sík dőlése és a Nasion helyzete; eltérés esetén a kiegészítő mérések döntenek.
14	**A**	**Hiperdivergens.** Mindkét szög jóval a klasszikus normák (FMA kb. 25°, SN-GoMe kb. 32°) felett van.
15	**D**	**A hátsó extrúziót jobban tolerálja, de erős a mélyharapásra való hajlam.** A hipodivergens mintázat tolerálja a hátsó extrúziót; a mélyharapásra és a recidívára való hajlamot szem előtt tartjuk.
16	**C**	**Az alsó metszők proklinációjának további fokozódása; parodontális és stabilitási kockázat.** A II. osztályú elasztikusok előre döntik az alsó metszőket; eleve proklinált metszőknél ez korlátozó tényező.
17	**B**	**Az overjet jelentős része a felső metszők proklinációjából ered.** Az U1-SN jóval a normál felett van, az ANB a normál határán: a dentális komponens dominál.
18	**A**	**Természetes dentoalveoláris kompenzáció: a felső metszők proklináltak, az alsók retroklináltak.** III. osztályban a metszők úgy dőlnek, hogy elfedjék a szkeletális eltérést; sebészi tervnél ezt a kompenzációt megszüntetjük.
19	**D**	**Gonion és Menton.** Az SN-GoMe az SN-sík és a Go-Me sík által bezárt szög.
20	**C**	**Porion és Orbitale.** A frankfurti horizontális a Porionon és az Orbitalén halad át.

Helyes válaszok: ___ / 10 Dátum: Ismétlés dátuma:

3. BLOKK · 21–30. KÉRDÉS

Tervezés és időzítés

Olvasmány: 3. modul · Klinikai Tervezés: a Problémalistától a Mechanikáig · Vizuális térképek: 19, 43–52 · 4. eszköz · 4 Lépéses Klinikai Tervező

21. kérdés

ESET

13 éves. II. osztály 1. alosztály, mélyharapás, enyhe torlódás. Meg kell írnod a problémalistát.

Melyik a helyes megközelítés?

A) Előbb kiválasztani a készüléket, és ahhoz igazítva felírni a problémákat

B) Csak a páciens panaszát felírni

C) A problémákat külön felírni szagittális, vertikális, transzverzális és helyigény szerint, majd rangsorolni őket

D) Csak a kefalometriai értékeket felsorolni

22. kérdés

ESET

8 éves. Egyetlen felső metsző elülső keresztharapásban. Centrikus relációban csücsök-csücsök helyzetbe hozható. Az alsó metszőn ínyrecesszió kezdődött.

Melyik a legmegfelelőbb döntés?

A) Várni a maradó fogazat teljes kialakulásáig

B) Mérlegelni a korai korrekciót

C) Ortognát műtétet tervezni

D) Csak éjszakai sínt adni

23. kérdés

ESET

7 éves. Enyhe II. osztályú hajlam, overjet 4 mm, trauma nem volt. A gyermek még nem áll készen a kezelésre.

Melyik a legmegfelelőbb megközelítés?

A) Követni és a növekedési szakaszban újraértékelni

B) Azonnal elkezdeni a rögzített kezelést

C) Felső premoláris extrakciót tervezni

D) Sebészi konzíliumot kérni

24. kérdés

ESET

18 éves férfi. III. osztály. ANB −6°, Wits −10 mm. Kifejezett panasz a profil miatt.

Melyik a legmegfelelőbb első lépés?

A) Azonnal kamuflázst kezdeni III. osztályú elasztikusokkal

B) Arcmaszkot javasolni

C) Követésre venni anélkül, hogy bármilyen lehetőséget felkínálnál

D) Igazolni a növekedés befejeződését, és ortognát sebészi konzíliumot javasolni

25. kérdés

ESET

16 éves lány. II. osztály, ANB 5°, a profil elfogadható. Az alsó ívben nincs torlódás, a növekedés nagyrészt befejeződött.

Melyik lehetőség jöhet szóba?

A) Négy premoláris extrakciója kötelező

B) Arcmaszk

C) Kamuflázs felső premoláris extrakcióval

D) Önmagában gyors felső állcsont-tágítás

26. kérdés

ESET

14 éves. Fél egységnyi II. osztály. Gyenge az együttműködés elasztikussal és kivehető készülékkel.

Melyik függ a legkevésbé az együttműködéstől?

A) Kivehető funkcionális készülék

B) Rögzített funkcionális készülék vagy minicsavarral támogatott mechanika

C) II. osztályú elasztikusok

D) Éjszaka viselt kivehető lemez

27. kérdés

ESET

40 éves. Parodontális csontvesztés és aktív gyulladás áll fenn.

Mikor kezdhető az ortodoncia?

A) A parodontális kezelés befejezése és a betegség stabilizálódása után

B) Azonnal; az ortodoncia csökkenti a gyulladást

C) Soha nem kezdhető

D) Csak az implantátumok behelyezése után

28. kérdés

ESET

A jobb felső laterális metsző veleszületetten hiányzik. A szemfog formája és színe megfelelő, az ínyszint eltérő.

Hogyan döntesz a résbezárásról vagy a résnyitásról?

A) Mindig helyet nyitunk implantátumnak

B) Mindig bezárjuk a rést

C) A döntés kizárólag a protetikusé

D) A szemfog morfológiáját, a színt, az ínyszintet, az okklúziót és a profilt együtt értékelve, csapatdöntéssel

29. kérdés

ESET

A mechanikai sorrendet tervezed.

Melyik a helyes sorrend?

A) Befejezés → nivellálás → munkafázis → retenció

B) Munkafázis → nivellálás → retenció → befejezés

C) Nivellálás-rendezés → munkafázis → befejezés → retenció

D) Retenció → nivellálás → befejezés → munkafázis

30. kérdés

ESET

Egy felnőtt esethez VTO-t készítesz.

Mi a VTO fő célja?

A) A végeredmény garantálása

B) A tervezett változások várható hatásának előzetes megjelenítése a profilon és az okklúzión

C) A rendelőd által használt beleegyező nyilatkozat kiváltása

D) A kefalometria fölöslegessé tétele

3. blokk · Válaszok és kommentárok

KÉRDÉS	VÁLASZ	KOMMENTÁR
21	**C**	**A problémákat külön felírni szagittális, vertikális, transzverzális és helyigény szerint, majd rangsorolni őket.** A problémalistát dimenziók szerint írjuk; a mechanikát választjuk utoljára.
22	**B**	**Mérlegelni a korai korrekciót.** A funkcionális csúszás és a parodontális terhelés a korai kezelés klasszikus indokai.
23	**A**	**Követni és a növekedési szakaszban újraértékelni.** Ha nincs indok a korai kezelésre, a megfelelő időben végzett egyfázisú kezelés többnyire hatékonyabb.
24	**D**	**Igazolni a növekedés befejeződését, és ortognát sebészi konzíliumot javasolni.** A nagy szkeletális eltérés és a profilpanasz miatt a sebészi lehetőséget meg kell beszélni.
25	**C**	**Kamuflázs felső premoláris extrakcióval.** Rendezett alsó ívnél tervezhető kamuflázs csak felső extrakcióval, moláris II. osztályú befejezéssel.
26	**B**	**Rögzített funkcionális készülék vagy minicsavarral támogatott mechanika.** Gyenge együttműködésnél azok a lehetőségek kerülnek előtérbe, amelyek nem függnek attól, hogy a páciens be- és kiveszi-e a készüléket.
27	**A**	**A parodontális kezelés befejezése és a betegség stabilizálódása után.** Aktív parodontális betegségben a fogmozgatás felgyorsíthatja a csontvesztést.
28	**D**	**A szemfog morfológiáját, a színt, az ínyszintet, az okklúziót és a profilt együtt értékelve, csapatdöntéssel.** Hiányzó laterálisnál nincs egyetlen helyes út; az esztétikai, okklúziós és parodontális szempontokat együtt mérlegeljük.
29	**C**	**Nivellálás-rendezés → munkafázis → befejezés → retenció.** A nivellálás befejezése előtt nem térünk át merev munkaívekre és résbezárásra.
30	**B**	**A tervezett változások várható hatásának előzetes megjelenítése a profilon és az okklúzión.** A VTO tervezőeszköz, nem az eredmény garanciája.

Helyes válaszok: ___ / 10 Dátum: Ismétlés dátuma:

4. BLOKK · 31–40. KÉRDÉS

Helygazdálkodás

Olvasmány: 4. modul · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakció és Lehorgonyzás Mikrocsavarokkal · Vizuális térképek: 14, 16, 18, 53–61 · 2. eszköz · Döntési Térkép: Extrakció vagy Megtartás?

31. kérdés

ESET

17 éves. I. osztály. Alul 9 mm torlódás, bimaxilláris protrúzió, előreálló ajkak.

Melyik a legerősebb lehetőség?

A) Csak IPR

B) Extrakciós terv

C) Extrakció nélküli terv a metszők további előredöntésével

D) Csak követés

32. kérdés

ESET

26 éves. Az alsó metszőkön 2,5 mm torlódás. Háromszög alakú koronák, jó szájhigiénia.

Melyik lehetőség megfelelő?

A) IPR

B) Négy premoláris extrakciója

C) Gyors felső állcsont-tágítás

D) Ortognát műtét

33. kérdés

ESET

Magas szuvasodási kockázat, elégtelen szájhigiénia és kicsi koronák. Az alsó metszőkön enyhe torlódás.

Melyik a helyes döntés az IPR-ről?

A) A lehető legtöbb IPR-t végezni

B) Az IPR után nem polírozni

C) A kockázati tényezőket figyelmen kívül hagyni

D) Kerülni az IPR-t, vagy nagyon korlátozottan végezni

34. kérdés

ESET

10 éves. Kétoldali hátsó kereszttharapás. Szűk felső állcsont, mély szájpadlás.

Melyik a legmegfelelőbb lehetőség?

A) Csak keresztelasztikusok

B) Az alsó ív szűkítése

C) Gyors felső állcsont-tágítás (RME)

D) Várni a növekedés végéig

35. kérdés

ESET

22 éves. Szkeletális transzverzális szűkület. Vékony buccalis csont, vékony íny-fenotípus.

Melyik megközelítés helyesebb?

A) Tágítás pusztán a fogak buccalis döntésével

B) A minicsavarral vagy sebészileg támogatott tágítás mérlegelése parodontológiai véleménnyel

C) RME alkalmazása minden előzetes értékelés nélkül

D) A transzverzális szűkület figyelmen kívül hagyása

36. kérdés

ESET

9 éves. A bal alsó második tejmoláris korán elveszett. Az alatta lévő premoláris áttöréséig még van idő. Helyvesztés még nincs.

Melyik a legmegfelelőbb lehetőség?

A) Helytartó

B) Semmit sem tenni

C) Azonnali premoláris extrakció

D) III. osztályú elasztikusok

37. kérdés

ESET

11 éves. Az alsó második tejmolárisok még a helyükön vannak. Az alsó metszőkön 3 mm torlódás.

Melyik lehetőség járulhat hozzá a helynyeréshez?

A) A tejmolárisok korai eltávolítása

B) Az alsó metszők eltávolítása

C) Gyors felső állcsont-tágítás

D) Linguális ív a leeway-tér megőrzésére

38. kérdés

ESET

Felső moláris disztalizáció zajlik.

Milyen mellékhatás várható a lehorgonyzási egységen?

A) A metszők retroklinációja

B) Az alsó molárisok disztalizációja

C) A premolárisok és a metszők meziális mozgása és a metszők proklinációja

D) Az overbite spontán növekedése

39. kérdés

ESET

16 éves. II. osztály 1. alosztály. Az alsó ív rendezett. Csak a felső első premolárisokat távolítjuk el.

Milyen moláris és szemfogviszony a cél a befejezéskor?

A) Moláris I. osztály, szemfog I. osztály

B) Moláris II. osztály, szemfog I. osztály

C) Moláris III. osztály, szemfog II. osztály

D) Moláris I. osztály, szemfog II. osztály

40. kérdés

ESET

Az alsó ívben extrakció szükséges, de nem szeretnénk, hogy az alsó metszők túlságosan hátrahúzódjanak.

Melyik extrakció részesíthető előnyben?

A) Alsó második premoláris

B) Alsó első premoláris

C) Alsó szemfog

D) Alsó centrális metsző

4. blokk · Válaszok és kommentárok

KÉRDÉS	VÁLASZ	KOMMENTÁR
31	**B**	**Extrakciós terv.** A súlyos torlódás és a protrúzió két erős érv az extrakció mellett.
32	**A**	**IPR.** Az enyhe torlódás és a háromszög alakú korona kedvező feltétel az IPR-hez.
33	**D**	**Kerülni az IPR-t, vagy nagyon korlátozottan végezni.** A szuvasodási kockázat és a kis koronaméret az IPR ellen szól.
34	**C**	**Gyors felső állcsont-tágítás (RME).** Növekedési korban a szkeletális transzverzális szűkület RME-vel kezelhető.
35	**B**	**A minicsavarral vagy sebészileg támogatott tágítás mérlegelése parodontológiai véleménnyel.** Felnőttnél és vékony fenotípusnál a pusztán dentális tágítás növeli az íny- és csontvesztés kockázatát.
36	**A**	**Helytartó.** A tejmoláris korai elvesztésekor a maradó moláris meziális vándorlása helyvesztéshez vezethet.
37	**D**	**Linguális ív a leeway-tér megőrzésére.** Ha a tejmolárisok cseréjekor felszabaduló leeway-teret megőrizzük, az segíthet a torlódás megoldásában.
38	**C**	**A premolárisok és a metszők meziális mozgása és a metszők proklinációja.** A disztalizáló erővel egyenlő és ellentétes erő előre tolja a lehorgonyzó fogakat.
39	**B**	**Moláris II. osztály, szemfog I. osztály.** Csak felső extrakciónál a felső molárisok a helyükön maradnak; a szemfogakat I. osztályba visszük.
40	**A**	**Alsó második premoláris.** A második premoláris eltávolítása lehetővé teszi, hogy az alsó metszők kevésbé húzódjanak hátra, és a molárisok meziálisan mozogjanak.

Helyes válaszok: ___ / 10 Dátum: Ismétlés dátuma:

5. BLOKK · 41–50. KÉRDÉS

Lehorgonyzás és minicsavarok

Olvasmány: 4. modul · Helygazdálkodás: IPR, Tágítás, Extrakció és Lehorgonyzás Mikrocsavarokkal · Vizuális térképek: 11, 62–66

41. kérdés

ESET

Bimaxilláris protrúzió. Négy premoláris extrakciója; a cél a metszők lehető legnagyobb hátrahúzása.

Melyik a legmegbízhatóbb lehorgonyzási lehetőség?

A) Direkt lehorgonyzás minicsavarral
B) Elasztikus lánc lehorgonyzási támasz nélkül
C) Csak II. osztályú elasztikusok
D) Csak éjszakai sín

42. kérdés

ESET

A résbezárás során a felső molárisok 3 mm-t mozdultak meziálisan, az overjet a vártnál kevésbé csökkent.

Mi a probléma?

A) Gyökérreszorpció
B) Funkcionális csúszás
C) Bolton-eltérés
D) A lehorgonyzás elvesztése

43. kérdés

ESET

TPA használatát fontolgatod.

Mi a TPA fő hatása?

A) Önmagában abszolút szagittális lehorgonyzást ad
B) Intrudálja az alsó metszőket
C) Megőrzi a molárisok közötti transzverzális viszonyt és kontrollálja a moláris rotációt
D) Szkeletálisan tágítja a felső állcsontot

44. kérdés

ESET

A felső ívben kiegészítő lehorgonyzásra Nance-készüléket terveznek.

Honnan kapja a támasztást a Nance-készülék?

A) Az alsó metszőkről
B) Az elülső szájpadlás nyálkahártyáján felfekvő akrilgombról
C) Minicsavarokról
D) Extraorális területről

45. kérdés

ESET

Minicsavar behelyezését tervezed.

Mit ellenőrzöl elsősorban a behelyezés előtt?

A) A gyökerek közötti távolságot és a csontmennyiséget; ha lehet, tapadó ínyt

B) Csak a páciens által preferált területet

C) Csak a bracket színét

D) Semmilyen radiológiai értékelés nem szükséges

46. kérdés

ESET

A minicsavar néhány héttel a behelyezés után mozog.

Melyek a legvalószínűbb okok?

A) Mindig a páciens életkora az egyetlen ok

B) Nem megfelelő elasztikusszín

C) A brackettípus megváltozása

D) Gyökérkontaktus, elégtelen csont vagy körülötte lévő gyulladás

47. kérdés

ESET

A minicsavart egy premolárishoz kötötték, az erőt a premolárisról fejtik ki.

Milyen típusú ez a lehorgonyzás?

A) Direkt lehorgonyzás

B) Extraorális lehorgonyzás

C) Indirekt lehorgonyzás

D) Kölcsönös lehorgonyzás

48. kérdés

ESET

Felnőtt. Az antagonista fog elvesztése miatt a felső első moláris extrudált. A pótláshoz vertikális hely kell.

Milyen mechanika jöhet szóba?

A) A moláris további extrúziója

B) Minicsavarral támogatott moláris intrúzió

C) II. osztályú elasztikusok

D) Gyors felső állcsont-tágítás

49. kérdés

ESET

Felnőtt. Hiperdivergens mintázat, 3 mm-es elülső nyitott harapás.

Melyik lehetőség célozza a vertikális problémát?

A) A minicsavaros hátsó intrúzió mérlegelése

B) Hosszan tartó II. osztályú elasztikusok

C) Hátsó extrúzió

D) Kontrollálatlan dentális tágítás

50. kérdés

ESET

A minicsavar körül ínyhiperplázia és érzékenység jelentkezik.

Mi az első lépés?

A) Az erő növelése

B) A lelet figyelmen kívül hagyása

C) Egy második csavar behelyezése a minicsavar mellé

D) A higiénia és a gyulladás kontrollja; ha nem javul, a minicsavar eltávolítása és más terület mérlegelése

5. blokk · Válaszok és kommentárok

KÉRDÉS	VÁLASZ	KOMMENTÁR
41	**A**	**Direkt lehorgonyzás minicsavarral.** Maximális lehorgonyzást igénylő esetekben a minicsavar a legkevesebb együttműködést kívánó megbízható lehetőség.
42	**D**	**A lehorgonyzás elvesztése.** A molárisok meziális mozgása és az overjet elégtelen csökkenése a lehorgonyzásvesztés tipikus jelei.
43	**C**	**Megőrzi a molárisok közötti transzverzális viszonyt és kontrollálja a moláris rotációt.** A TPA a szagittális lehorgonyzáshoz csak korlátozottan járul hozzá; fő hatása a transzverzális és a rotációs kontroll.
44	**B**	**Az elülső szájpadlás nyálkahártyáján felfekvő akrilgombról.** A Nance-készülék az akrilgombbal a palatinális nyálkahártyán támaszkodik; a gomb alatti higiéniát ellenőrizzük.
45	**A**	**A gyökerek közötti távolságot és a csontmennyiséget; ha lehet, tapadó ínyt.** A gyökérkontaktus és az elégtelen csont a kudarc leggyakoribb okai közé tartozik.
46	**D**	**Gyökérkontaktus, elégtelen csont vagy körülötte lévő gyulladás.** Mozgó minicsavarnál értékeljük a helyzetet, a csontot és a higiéniát; szükség esetén más területre helyezzük át.
47	**C**	**Indirekt lehorgonyzás.** Indirekt lehorgonyzásnál a minicsavar egy fogat rögzít, és az erőt erről a fogról fejtjük ki.
48	**B**	**Minicsavarral támogatott moláris intrúzió.** A minicsavar lehetővé teszi egyetlen moláris intrúzióját a szomszédos fogak befolyásolása nélkül.
49	**A**	**A minicsavaros hátsó intrúzió mérlegelése.** A hátsó intrúzió lehetővé teszi a mandibula előre-felfelé rotációját, így csökkentheti a nyitott harapást.
50	**D**	**A higiénia és a gyulladás kontrollja; ha nem javul, a minicsavar eltávolítása és más terület mérlegelése.** A gyulladás növeli a kudarc kockázatát; először a higiéniát és a terhelést értékeljük.

Helyes válaszok: ___ / 10 Dátum: Ismétlés dátuma:

6. BLOKK · 51–60. KÉRDÉS

II. osztály

Olvasmány: 5. modul · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály · Vizuális térképek: 12, 15, 67–72, 77 · 3. eszköz · II. osztály – III. osztály Vizuális Elkülönítő

51. kérdés

ESET

12 éves. Moláris II. osztály. ANB 2°. A felső metszők proklináltak.

Túlnyomóan milyen jellegű ez a II. osztály?

A) Szkeletális, mandibuláris retrúzió
B) Szkeletális, maxilláris prognátia
C) Funkcionális csúszás
D) Dentális

52. kérdés

ESET

11 éves fiú. SNB 74°, ANB 7°, FMA 24°. Közel a növekedési csúcshoz, jól együttműködik.

Melyik lehetőség kerül előtérbe?

A) Ortognát műtét
B) Arcmaszk
C) Funkcionális készülék
D) Csak alsó premoláris extrakció

53. kérdés

ESET

10 éves. Overjet 10 mm. Korábbi trauma és ajakcsapda áll fenn.

Melyik a legmegfelelőbb döntés?

A) Várni a maradó fogazat teljes kialakulásáig
B) Mérlegelni az overjet korai csökkentését
C) Csak az alsó metszőket előrehozni
D) Csak követni

54. kérdés

ESET

Twin Block-kezelés zajlik.

Melyik a legjellemzőbb dentoalveoláris mellékhatás?

A) Az alsó metszők proklinációja
B) Az alsó metszők retroklinációja
C) A felső metszők proklinációja
D) Hátsó kereszttharapás kialakulása

55. kérdés

ESET

II. osztályú elasztikusokat használnak.

Melyik tipikus mellékhatás?

A) Az alsó metszők retroklinációja

B) A felső molárisok intrúziója

C) Az overjet növekedése

D) Az alsó molárisok extrúziója és az alsó metszők proklinációja

56. kérdés

ESET

FMA 35°. II. osztály, enyhe nyitott harapásra való hajlam. Hosszan tartó II. osztályú elasztikust fontolgatnak.

Melyik a helyes értelmezés?

A) Hiperdivergens páciensnél ez a legbiztonságosabb lehetőség

B) Nincs hatása a vertikális dimenzióra

C) Óvatosság szükséges; a moláris extrúzió hátrafelé rotálhatja a mandibulát, és ronthatja a profilt

D) Mindig bezárja a nyitott harapást

57. kérdés

ESET

II. osztály 2. alosztály, mély overbite.

Mit teszel először a kezelés során?

A) Azonnal elkezdeni a II. osztályú elasztikusokat

B) Korrigálni a felső centrálisok dőlését és megnyitni a mélyharapást

C) Eltávolítani az alsó metszőket

D) Először rögzítő készüléket behelyezni

58. kérdés

ESET

Még növekedésben lévő II. osztályú páciensnél aggályos az együttműködés.

Melyik lehetőség csökkenti az együttműködéstől való függést?

A) Rögzített funkcionális készülék

B) Kivehető funkcionális készülék

C) II. osztályú elasztikusok

D) Éjszakai sín

59. kérdés

ESET

20 éves. ANB 9°, overjet 11 mm, kifejezett mandibuláris retrúzió, panasz a profil miatt.

Melyik a legmegfelelőbb megközelítés?

A) Csak II. osztályú elasztikusok

B) Funkcionális készülék

C) Csak IPR

D) Ortognát sebészi konzílium

60. kérdés

ESET

II. osztályú kamuflázsban a felső metszőket hátrahúzzák.

Mire kell leginkább figyelni?

A) Hogy a metszők minél jobban felegyenesedjenek

B) Hogy az erő a lehető legnagyobb legyen

C) A torkkontrollra; a metszők túlzott retroklinációjának elkerülésére

D) Az overbite mélyülésére

6. blokk · Válaszok és kommentárok

KÉRDÉS	VÁLASZ	KOMMENTÁR
51	**D**	**Dentális.** Normális ANB mellett a II. osztályú viszonyt a fogak helyzete magyarázza.
52	**C**	**Funkcionális készülék.** A mandibuláris retrúzió, a normális vertikális mintázat és a kedvező növekedési szakasz megfelelő feltétel a funkcionális készülékhez.
53	**B**	**Mérlegelni az overjet korai csökkentését.** A megnövekedett overjet és a korábbi trauma erős érv a korai beavatkozás mellett.
54	**A**	**Az alsó metszők proklinációja.** Funkcionális készülékeknél az alsó metszők hajlamosak előredőlni; ezt követni kell.
55	**D**	**Az alsó molárisok extrúziója és az alsó metszők proklinációja.** A II. osztályú elasztikusok előre húzzák az alsó ívet, és extrudálhatják az alsó molárisokat.
56	**C**	**Óvatosság szükséges; a moláris extrúzió hátrafelé rotálhatja a mandibulát, és ronthatja a profilt.** A hiperdivergens mintázat érzékeny az extrudáló mechanikákra.
57	**B**	**Korrigálni a felső centrálisok dőlését és megnyitni a mélyharapást.** A retroklinált metszők és a mélyharapás korrekciója nélkül a szagittális viszony nem olvasható le helyesen.
58	**A**	**Rögzített funkcionális készülék.** A rögzített funkcionális készülékek nem függnek attól, hogy a páciens be- és kiveszi-e őket.
59	**D**	**Ortognát sebészi konzílium.** Befejezett növekedés melletti nagy szkeletális eltérésnél a kamuflázs a határait feszegeti.
60	**C**	**A torkkontrollra; a metszők túlzott retroklinációjának elkerülésére.** A torkvesztés az esztétikát és az overbite-ot is kedvezőtlenül befolyásolja.

Helyes válaszok: ___ / 10 Dátum: Ismétlés dátuma:

7. BLOKK · 61–70. KÉRDÉS

III. osztály

Olvasmány: 5. modul · Szagittális Problémák: II. és III. Osztály · Vizuális térképek: 13, 73–76

61. kérdés

ESET

7 éves. Elülső kereszharapás. Centrikus relációban a metszők csücsök-csücsök helyzetben vannak. Nyugalomban egyenes profil.

Mi a legvalószínűbb diagnózis?

A) Szkeletális III. osztály

B) II. osztály 2. alosztály

C) Pszeudo-III. osztály

D) Ollós harapás

62. kérdés

ESET

8 éves. SNA 77°, SNB 80°, ANB −3°. Negatív overjet.

Melyik lehetőség jöhet szóba?

A) Azonnali ortognát műtét

B) Korai maxilláris protrakció arcmaszkkal

C) II. osztályú elasztikusok

D) Alsó premoláris extrakció

63. kérdés

ESET

9 éves. Az apának III. osztálya van. ANB −2°.

Mit kell elmondani a családnak?

A) A korai kezelés lehetséges előnyét, azt, hogy a növekedéssel recidíva léphet fel, és később további kezelés válhat szükségessé

B) Hogy a korai kezelés biztosan és véglegesen megoldja a problémát

C) Hogy semmilyen kezelés nem segít

D) Hogy ez csak esztétikai probléma

64. kérdés

ESET

Felnőtt. ANB −2°, a profil elfogadható, a páciens nem kér műtétet.

Hogyan mozgatod a metszőket kamuflázsban?

A) A felső metszőket hátra, az alsókat előre döntjük

B) Mindkét metszőt felegyenesítjük

C) A metszőket nem mozgatjuk

D) A felső metszőket előre, az alsókat hátra döntjük

65. kérdés

ESET

Ortodonciai előkészítés III. osztályú ortognát műtét előtt.

Mi az előkészítő szakasz célja?

A) A kompenzáció fokozása

B) A negatív overjet teljes megszüntetése

C) Dekompenzáció: a metszők helyes dőlésbe állítása a bazális csonthoz képest

D) Olyan mértékű korrekció, hogy ne legyen szükség műtétre

66. kérdés

ESET

III. osztályú elasztikusokat használnak.

Melyik a tipikus mellékhatás?

A) Az alsó metszők proklinációja

B) A felső metszők proklinációja, az alsó metszők retroklinációja és a felső molárisok extrúziója

C) A felső molárisok intrúziója

D) Az overjet növekedése

67. kérdés

ESET

Arcmaszkos kezelést terveznek.

Melyik a legmegfelelőbb időszak?

A) Korai vegyes fogazat, amíg a maxilla még növekszik

B) A növekedés befejeződése után

C) Csak felnőttkorban

D) Évekkel a maradó második molárisok áttörése után

68. kérdés

ESET

26 éves. Egyetlen felső laterális metsző keresztharapásban. Az ívben kb. 2 mm hely hiányzik.

Milyen sorrendben korrigálsz?

A) Először erővel labiálisan tolni a metszőt

B) Ortognát műtét

C) Semmit sem tenni

D) Először helyet nyitni, majd labiálisan mozgatni a metszőt

69. kérdés

ESET

Elülső keresztharapás.

Melyik lelet utal valódi szkeletális III. osztályra?

A) A metszők centrikus relációban csücsök-csücsök helyzetbe kerülnek

B) Csak egyetlen metsző van keresztharapásban

C) A negatív overjet centrikus relációban is megmarad, konkáv profil és családi előfordulás

D) Egyenes profil és funkcionális csúszás

70. kérdés

ESET

15 éves fiú. Szkeletális III. osztály, műtétet fontolgatnak. A növekedés még tart.

Hogyan határozod meg a műtét időzítését?

A) Azonnal elvégezzük, még a növekedés alatt

B) Megvárjuk a növekedés befejeződését; sorozatfelvételekkel igazoljuk

C) Életkortól függetlenül ugyanarra a napra tervezzük

D) Az időzítés nem befolyásolja az eredményt

7. blokk · Válaszok és kommentárok

KÉRDÉS	VÁLASZ	KOMMENTÁR
61	**C**	**Pszeudo-III. osztály.** A centrikus relációban elérhető csücsök-csücsök kontaktus és az egyenes profil funkcionális előrecsúszásra utal.
62	**B**	**Korai maxilláris protrakció arcmaszkkal.** Maxilláris retrúziónál a korai protrakciót a növekedési szakaszban mérlegeljük.
63	**A**	**A korai kezelés lehetséges előnyét, azt, hogy a növekedéssel recidíva léphet fel, és később további kezelés válhat szükségessé.** Családi III. osztálynál a növekedés megváltoztathatja az eredményt; az elvárásokat már az elején helyesen kell beállítani.
64	**D**	**A felső metszőket előre, az alsókat hátra döntjük.** A kamuflázs dentoalveoláris kompenzációval fedi el a szkeletális eltérést; a határait tiszteletben tartjuk.
65	**C**	**Dekompenzáció: a metszők helyes dőlésbe állítása a bazális csonthoz képest.** A dekompenzáció alatt a negatív overjet átmenetileg nőhet; erről a pácienst előre tájékoztatjuk.
66	**B**	**A felső metszők proklinációja, az alsó metszők retroklinációja és a felső molárisok extrúziója.** A III. osztályú elasztikusok előre húzzák a felső ívet, hátra az alsót.
67	**A**	**Korai vegyes fogazat, amíg a maxilla még növekszik.** A protrakció szkeletális hatása korai szakaszban nagyobb.
68	**D**	**Először helyet nyitni, majd labiálisan mozgatni a metszőt.** Hely nélkül a fog nem állítható be az ívbe; szükség esetén ideiglenes harapásemelőket alkalmazunk.
69	**C**	**A negatív overjet centrikus relációban is megmarad, konkáv profil és családi előfordulás.** Pszeudo-III. osztálynál centrikus relációban lehetséges a csücsök-csücsök kontaktus; valódi III. osztálynál nem.
70	**B**	**Megvárjuk a növekedés befejeződését; sorozatfelvételekkel igazoljuk.** A növekedés alatt végzett műtét után a mandibula további növekedése ronthatja az eredményt.

Helyes válaszok: ___ / 10 Dátum: Ismétlés dátuma:

8. BLOKK · 71–80. KÉRDÉS

Vertikális és Transzverzális Problémák

Olvasmány: 6. modul · Vertikális és Transzverzális Problémák · Vizuális térképek: 4–6, 79–92

71. kérdés

ESET

9 éves. Ujjszopási szokás. 3 mm-es elülső nyitott harapás. FMA 26°.

Mi a legvalószínűbb típus és az első cél?

A) Szkeletális nyitott harapás; ortognát műtét

B) Szokás okozta dentális nyitott harapás; először a szokás elhagyása

C) Funkcionális csúszás; RME

D) Mélyharapás; intrúzió

72. kérdés

ESET

14 éves. FMA 36°, megnövekedett elülső alsó arcmagasság, 4 mm-es elülső nyitott harapás.

Mire utal ez a kép?

A) Szkeletális nyitott harapás; a vertikális kontroll az elsődleges

B) Kizárólag dentális nyitott harapás

C) Hipodivergens mintázat

D) Mélyharapásra való hajlam

73. kérdés

ESET

11 éves. Nyeléskor a nyelv a metszők közé kerül. Beszédben az „sz” hang torzul. 2 mm-es nyitott harapás.

Melyik a legmegfelelőbb megközelítés?

A) Bezárás kizárólag vertikális elasztikusokkal

B) Várakozás minden beavatkozás nélkül

C) Premoláris extrakció

D) Multidiszciplináris terv logopédussal, szükség esetén nyelvrács

74. kérdés

ESET

Overbite 6 mm. Nyugalomban túl sok látszik a felső metszőkből. Mosolykor látszik az íny.

Hogyan nyitod meg a mélyharapást?

A) A felső metszők extrúziójával

B) Csak hátsó extrúzióval

C) Elsősorban a felső metszők intrúziójával

D) II. osztályú elasztikusokkal

75. kérdés

ESET

Overbite 6 mm. Nyugalomban kevés látszik a felső metszőkből. FMA 20°.

Melyik lehetőség megfelelőbb?

A) A felső metszők intrúziója

B) Hátsó extrúzió és/vagy az alsó metszők intrúziója

C) Hátsó intrúzió

D) Semmilyen vertikális mechanika

76. kérdés

ESET

24 éves. Csak a bal felső első moláris van keresztharapásban. A felső ív szélessége megfelelő.

Melyik a legmegfelelőbb megközelítés?

A) Lokális dentális korrekció

B) Gyors felső állcsont-tágítás

C) Sebészileg támogatott tágítás

D) Arcmaszk

77. kérdés

ESET

Egyetlen moláris keresztharapásához keresztelasztikust használnak.

Melyik a tipikus mellékhatás?

A) A fogak intrúziója

B) A metszők proklinációja

C) A középvonal korrekciója

D) A fogak extrúziója

78. kérdés

ESET

A felső hátsó fogak teljesen az alsók buccalis oldalán zárnak.

Mi ennek a harapásnak a neve?

A) Hátsó keresztharapás

B) Nyitott harapás

C) Ollós harapás

D) Funkcionális csúszás

79. kérdés

ESET

18 éves. Kétoldali hátsó keresztharapás. Vékony íny-fenotípus, a premolárisok már buccalisan dőltek.

Melyik lehetőség biztonságosabb?

A) A fogak további buccalis döntése

B) A szkeletális tágítási lehetőségek mérlegelése parodontológiai véleménnyel

C) Hosszan folytatott keresztelasztikus

D) Semmilyen értékelés

80. kérdés

ESET

Mosolykor sok íny látszik. A klinikai koronák rövidek. A metszők láthatósága normális.

Milyen okra kell gondolni?

A) Passzív áttörés; parodontológiai értékelés

B) A vertikális maxilláris túlnövekedés biztos diagnózis

C) Mandibuláris prognátia

D) Funkcionális csúszás

8. blokk · Válaszok és kommentárok

KÉRDÉS	VÁLASZ	KOMMENTÁR
71	**B**	**Szokás okozta dentális nyitott harapás; először a szokás elhagyása.** Normális vertikális mintázatnál a szokással együtt járó nyitott harapás többnyire dentális.
72	**A**	**Szkeletális nyitott harapás; a vertikális kontroll az elsődleges.** A magas FMA és a megnövekedett elülső alsó arcmagasság szkeletális komponensre utal.
73	**D**	**Multidiszciplináris terv logopédussal, szükség esetén nyelvrács.** Az izomfunkció kezelése nélkül bezárt nyitott harapás hajlamos a recidívára.
74	**C**	**Elsősorban a felső metszők intrúziójával.** A metszők túlzott láthatósága miatt esztétikailag a felső metszők intrúziója az előnyösebb.
75	**B**	**Hátsó extrúzió és/vagy az alsó metszők intrúziója.** Kevés metszőláthatóságnál a felső intrúzió rontja a mosolyt; az alacsony szögű mintázat tolerálja a hátsó extrúziót.
76	**A**	**Lokális dentális korrekció.** Az egyetlen fogra korlátozódó kereszharapás és a megfelelő ívszélesség dentális problémát jelez.
77	**D**	**A fogak extrúziója.** A keresztelasztikusok vertikális komponense extrudálja a fogakat; főleg hiperdivergens páciensnél kell figyelni.
78	**C**	**Ollós harapás.** Ollós harapásnál a kontaktus buccolingualis irányban teljesen megszűnt.
79	**B**	**A szkeletális tágítási lehetőségek mérlegelése parodontológiai véleménnyel.** Kompenzatórikusan megdőlt fogaknál a további dentális tágítás növeli a parodontális kockázatot.
80	**A**	**Passzív áttörés; parodontológiai értékelés.** A rövid klinikai koronák és a normális metszőláthatóság passzív áttörésre utalnak.

Helyes válaszok: ___ / 10 Dátum: Ismétlés dátuma:

9. BLOKK · 81–90. KÉRDÉS

Kiegészítő Mechanikák

Olvasmány: 7. modul · Kiegészítő Mechanikák · Vizuális térképek: 93–104

81. kérdés

ESET

Résbezárás közben a metszőknél mélyül az overbite, és elvész a tork. Az ív kicsi, az erő nagy.

Min kell változtatni?

A) Csökkenteni az erőt, a slotot jobban kitöltő négyszögletes acélívre váltani és kontrollálni a torkot

B) Tovább növelni az erőt

C) Vékonyabb kerek ívre váltani

D) Figyelmen kívül hagyni az overbite mélyülését

82. kérdés

ESET

Csúszó mechanikával kezdenéd a résbezárást.

Mi a kezdés feltétele?

A) A rugalmas NiTi ív maradjon a helyén

B) A bracketek felragasztása még ne legyen teljes

C) A rögzítő készülék már legyen behelyezve

D) A nivellálás legyen befejezve, és legyen megfelelő négyszögletes munkaív

83. kérdés

ESET

Hurkos (loop) mechanikát fontolgatnak.

Mi a fő előnye?

A) Egyáltalán nem igényel aktiválást

B) Megkönnyíti a higiéniát

C) Súrlódásmentes; az erő és a nyomaték a hajlítás geometriájával állítható

D) A páciens együttműködésén múlik

84. kérdés

ESET

Egy kifejezetten rotált laterális metszőt korrigáltak.

Mi a rotációs recidíva fő oka?

A) A bracket színének megváltozása

B) A szupraalveoláris ínyrostok késői átrendeződése

C) Az overjet növekedése

D) A minicsavar használatának hiánya

85. kérdés

ESET

Palatinálisan retineált felső szemfog. Van hely, a helyzetet meghatározták.

Mi a fontos a trakció előtt?

A) Merev lehorgonyzási egység és a szomszédos gyökerektől távolodó erőirány megtervezése

B) Az erő legyen a lehető legnagyobb

C) A lehorgonyzó fogak maradjanak rugalmas íven

D) Ne készüljön kiegészítő képalkotás

86. kérdés

ESET

A retineált szemfog trakciója során hónapok óta nincs mozgás, a lehorgonyzó fogak intrudálódnak.

Mire kell gondolni?

A) Megduplázni az erőt

B) Figyelmen kívül hagyni a lehorgonyzó fogak intrúzióját

C) Áttérni a retencióra

D) Ankilózis gyanúja; részletes kivizsgálás (4. útmutató · Trauma és Ankilózis)

87. kérdés

ESET

Az alsó második molárist felállítják.

Melyik a tipikus mellékhatás?

A) A moláris intrúziója

B) A metszők retroklinációja

C) A moláris extrúziója és korai okklúziós kontaktus

D) Hátsó kereszttharapás

88. kérdés

ESET

A felső ívben enyhe-közepes dentoalveoláris tágítás és moláris derotáció szükséges.

Melyik készülék megfelelő?

A) Arcmaszk

B) Quad helix

C) Twin Block

D) Fix linguális rögzítő

89. kérdés

ESET

Pendulummal felső moláris disztalizációt végeztek.

Milyen mellékhatás várható?

A) A premolárisok és a metszők meziális elmozdulása; a molárisok disztális billenése

B) A metszők retroklinációja

C) A molárisok meziális billenése

D) Az alsó ív tágulása

90. kérdés

ESET

A felső centrálison íny alá terjedő törés. A gyökér hossza elegendő. Restaurációs szél szükséges.

Mi lehet az ortodoncia hozzájárulása?

A) Ortodonciai intrúzió

B) Gyors felső állcsont-tágítás

C) III. osztályú elasztikusok

D) Ortodonciai extrúzió (kényszerített előtörés)

9. blokk · Válaszok és kommentárok

KÉRDÉS	VÁLASZ	KOMMENTÁR
81	**A**	**Csökkenteni az erőt, a slotot jobban kitöltő négyszögletes acélívre váltani és kontrollálni a torkot.** A nem merev ív és a túl nagy erő a metszők kontrollálatlan hátradőléséhez vezet.
82	**D**	**A nivellálás legyen befejezve, és legyen megfelelő négyszögletes munkaív.** A nivellálás vége előtt kezdett résbezárás a tork- és rotációkontroll elvesztéséhez vezet.
83	**C**	**Súrlódásmentes; az erő és a nyomaték a hajlítás geometriájával állítható.** A hurkok kiküszöbölik a súrlódást, de pontos hajlítást és aktiválást igényelnek.
84	**B**	**A szupraalveoláris ínyrostok késői átrendeződése.** A szupraalveoláris rostok sokáig feszesek maradnak; retenciót és szükség esetén fiberotómiát mérlegelünk.
85	**A**	**Merev lehorgonyzási egység és a szomszédos gyökerektől távolodó erőirány megtervezése.** Rossz erőiránynál nő a szomszédos gyökerek reszorpciójának kockázata.
86	**D**	**Ankilózis gyanúja; részletes kivizsgálás (4. útmutató · Trauma és Ankilózis).** A mozdulatlanság és a lehorgonyzó fogakon jelentkező mellékhatás ankilózisra utal.
87	**C**	**A moláris extrúziója és korai okklúziós kontaktus.** Felállításkor a meziális gyökércsúcs körüli rotáció megemeli a molárist.
88	**B**	**Quad helix.** A quad helixet enyhe-közepes dentális tágításra és moláris derotációra használjuk.
89	**A**	**A premolárisok és a metszők meziális elmozdulása; a molárisok disztális billenése.** A lehorgonyzási egység előre mozdul; a molárisok kontrollálatlanul disztálisan billenhetnek.
90	**D**	**Ortodonciai extrúzió (kényszerített előtörés).** Az extrúzió a törésvonalat az íny fölé hozza, és megkönnyíti a restaurációt.

Helyes válaszok: ___ / 10 Dátum: Ismétlés dátuma:

10. BLOKK · 91–100. KÉRDÉS

Befejezés, retenció, trauma és ankilózis

Olvasmány: 8. modul · Befejezés és Stabilitás · Vizuális térképek: 20, 105–114 · 2. útmutató · Ortodontiai Retenciós Kézikönyv · 4. útmutató · Trauma és Ankilózis

91. kérdés

ESET

A befejezésnél a szomszédos fogak marginális lécei eltérő szinten vannak.

Mit teszel?

A) Azonnal leveszed a bracketeket

B) Növeled az erőt

C) A különbséget a retencióval próbálod korrigálni

D) Áthelyezed az érintett bracketeket

92. kérdés

ESET

A befejező szakaszban a gyökérpárhuzamosságot ellenőrzöd.

Melyik a helyes megközelítés?

A) Csak a koronák megjelenését nézni

B) Semmilyen röntgenfelvételt nem használni

C) Panorámaröntgenen értékelni, a torzítást szem előtt tartva, a klinikai leletekkel együtt értelmezni

D) A panorámaképet pontos mérésnek tekinteni

93. kérdés

ESET

Befejezés. Az alsó középvonal 2 mm-rel jobbra tér el. Nincs szkeletális aszimmetria és funkcionális csúszás.

Melyik mechanika megfelelő?

A) Ortognát műtét

B) Dentális korrekció aszimmetrikus mechanikával vagy aszimmetrikus elasztikusokkal

C) Gyors felső állcsont-tágítás

D) Semmilyen korrekció

94. kérdés

ESET

A metszők viszonya jó, de a premoláris régióban gyengék a hátsó kontaktusok.

Melyik módszer alkalmazható?

A) Okklúziós beülés rugalmas befejező ívvel vagy rövid ideig viselt vertikális elasztikusokkal

B) Az erő növelése a bracketek levétele nélkül

C) Gyors felső állcsont-tágítás

D) Hátsó intrúzió

95. kérdés

ESET

Kiinduláskor felső diasztéma és az alsó metszőkön rotációk voltak.

Milyen retenciót javasolsz?

A) Nincs szükség retencióra

B) Csak egy hónapig kivehető lemez

C) Csak szájápolási tanács

D) Fix linguális rögzítő, szükség esetén éjszakai sínnel kiegészítve

96. kérdés

ESET

Gyenge higiéniájú, fix linguális rögzítőt nem kérő, de jól együttműködő páciens.

Melyik lehetőség jöhet szóba?

A) Semmilyen retenció

B) Ortognát műtét

C) Kivehető rögzítő (Hawley vagy átlátszó sín) és szoros követés

D) Fix linguális rögzítő a páciens kérése ellenére

97. kérdés

ESET

Három évvel a kezelés vége után visszatért az alsó metszőtorlódás. A páciens abbahagyta a sín viselését.

Mi a legvalószínűbb magyarázat?

A) A kezelés egyáltalán nem működött

B) A retenció elhanyagolása és az életkorral folytatódó fiziológiás változások

C) Kizárólag Bolton-eltérés

D) Kizárólag TMI-probléma

98. kérdés

ESET

Kontrollvizitkor észreveszed, hogy a fix linguális rögzítő egyik ragasztási pontja levált. A páciens nem vette észre.

Mit teszel?

A) Mielőbbi javítás, és annak ellenőrzése, történt-e fogmozgás az adott területen

B) Várakozás a következő éves kontrollig

C) A rögzítő teljes eltávolítása, új megoldás felajánlása nélkül

D) A lelet dokumentálásának mellőzése

99. kérdés

ESET

10 éves. Az anamnézisben felső centrális trauma szerepel. Ortodonciai kezelést terveznek.

Mit teszel a kiinduláskor?

A) Nem dokumentálod a trauma előzményét

B) A traumatizált fogra a legnagyobb erőt alkalmazod

C) Értékelés nélkül kezded a kezelést

D) A traumatizált fog klinikai és radiológiai értékelése és dokumentálása; kis erőkkel számoló terv

100. kérdés

ESET

Infraokklúzióban lévő tejmoláris, a szomszédos fogak fölé dőltek. Alatta nincs maradó fog.

Mi a legvalószínűbb diagnózis és a teendő?

A) Normális áttörés; csak várakozás

B) Funkcionális csúszás

C) Ankilózis; időben meghozott csapatdöntés a hely és a csontszint szempontjából

D) II. osztályú elasztikusok

10. blokk · Válaszok és kommentárok

KÉRDÉS	VÁLASZ	KOMMENTÁR
91	**D**	**Áthelyezed az érintett bracketeket.** A marginális lécek szintkülönbsége a bracketpozíció korrekcióját igényli.
92	**C**	**Panorámaröntgenen értékelni, a torzítást szem előtt tartva, a klinikai leletekkel együtt értelmezni.** A panorámakép jó tájékozódási pont, de torzítást tartalmazhat.
93	**B**	**Dentális korrekció aszimmetrikus mechanikával vagy aszimmetrikus elasztikusokkal.** A dentális eredetű középvonal-eltérés dentális mechanikával korrigálható.
94	**A**	**Okklúziós beülés rugalmas befejező ívvel vagy rövid ideig viselt vertikális elasztikusokkal.** A beülés (settling) javítja a hátsó kontaktusokat.
95	**D**	**Fix linguális rögzítő, szükség esetén éjszakai sínnel kiegészítve.** A diasztéma és a rotációk magas recidívakockázatú leletek.
96	**C**	**Kivehető rögzítő (Hawley vagy átlátszó sín) és szoros követés.** A rögzítőt a higiénia, az együttműködés és a páciens preferenciája alapján választjuk.
97	**B**	**A retenció elhanyagolása és az életkorral folytatódó fiziológiás változások.** A fogak egész életen át hajlamosak elmozdulni; ezért a retenciót hosszú távra tervezzük.
98	**A**	**Mielőbbi javítás, és annak ellenőrzése, történt-e fogmozgás az adott területen.** Ha a levált ragasztási pont észrevétlen marad, nem kívánt fogmozgás jöhet létre.
99	**D**	**A traumatizált fog klinikai és radiológiai értékelése és dokumentálása; kis erőkkel számoló terv.** A traumatizált fogakat a kezelés előtt értékeljük és dokumentáljuk; a részletek a 4. útmutatóban (Trauma és Ankilózis) találhatók.
100	**C**	**Ankilózis; időben meghozott csapatdöntés a hely és a csontszint szempontjából.** Ankilotikus tejmolárisnál a késlekedés a szomszédos fogak dőléséhez és csontszint-különbséghez vezethet.

Helyes válaszok: ___ / 10 Dátum: Ismétlés dátuma:

Oktatási célú anyag. Nem helyettesíti a klinikai vizsgálatot, az orvos döntését és a szakorvosi véleményt.

Következő lépés

Végeztél a 100 kérdéssel? Válaszd ki azt a két blokkot, amelyben a legkevesebb helyes válaszod volt, és térj vissza a hozzájuk tartozó hetekhez az 52 hetes esetgyakorló programban.

Ha a kefalometriai blokkban 8 alatt maradtál, nyisd meg a **Kefalometriai mérési gyakorlófüzetet**. A saját eseteid kollégákkal való megbeszéléséhez használd az **Esetbemutató sablonok kollégáknak** anyagot.

Hogy a széknél gyorsabban dönts, tartsd kéznél a Kézikönyvből a **2. eszköz · Döntési Térkép: Extrakció vagy Megtartás?** és a **3. eszköz · II. osztály – III. osztály Vizuális Elkülönítő** lapot.